

■ 脳卒中・嚥下評価

脳卒中後の嚥下障害 訴えなくても画像所見

歩行可能な外来45人、7人に訴えの乏しい障害

歩いて通院できる脳卒中経験者でも、「飲み込みに困っていない」という訴えだけでは嚥下障害を拾えないことがあります。発症から3か月以上たった虚血性脳卒中の成人45人を調べた後ろ向きの二次解析が出ました。

嚥下造影と質問紙EAT-10を比較すると、20人（44%）に画像上の嚥下障害があり、そのうち7

人はEAT-10が3点以下。訴えの乏しい嚥下障害は全体の16%でした。訴えのある群とない群で画像所見の重症度は同程度でした。研究ではDIGESTが1以上を障害と定義。EAT-10と口腔期の生理指標には関連がありましたが、DIGESTとの相関は有意ではありませんでした。

少人数で、嚥下造影を受けた集団の結果です。脳卒中経験者全体の有病率とはいえず、全員に造影を行うべきだと示した研究でもありません。それでも、退院後に「むせていない・歩けている」だけで判断せず、食事場面や栄養状態、既往を含めて再評価の必要性を考える材料になります。



症状の訴えと画像評価は、同じものを測っているわけではない。

出典 [Am J Speech Lang Pathol](#) ↗

数字で見る

45人

外来の脳卒中経験者

7人

訴えに乏しい嚥下障害

16%

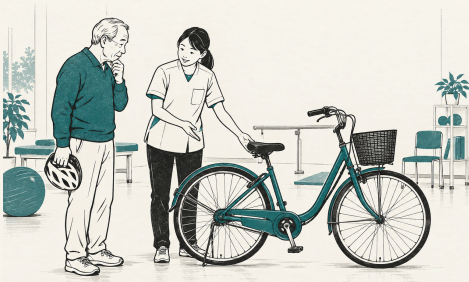
対象45人に占める割合

■ TKA・生活動作

TKA後の自転車再開 膝屈曲135度が目安候補

術後3か月に再開できた15人と、できなかった10人を比較。膝の屈曲可動域は平均133.3度と128.5度で、ROC解析によるカットオフは135度でした。術前の年齢にも差があり、可能群72.3歳、不可能群79.3歳でした。

著者は135度を再開の一つの目安としていますが、単施設・少人数の比較です。この角度だけで安全に乗れるとは判断で



きません。乗降、バランス、交通環境、車体の違いも確認し、「可動域の目標」と「屋外での再開判断」を分けて考えたい結果です。

出典 [総合理学療法学](#) ↗

■ 障害福祉・2027年度改定へ

リハ9団体が共同要望 自立訓練の提供を後押し

リハ関連9団体が9月29日、2027年度障害福祉報酬改定へ要望を提出し、10月8日に公表。病院・診療所と通所リハの指定申請を不要にすること、書類簡素化と全国共通の運用、導入手順の周知、報酬引き上げを求めています。

2025年8月の施設アンケートでは、改定後の導入は回答の1%（3施設）、予定は3%（11施設）。全



国の導入率ではありません。変更の決定でなく要望です。退院後の外出や復職など、地域生活と障害福祉をつなぐ課題です。

出典 [日本理学療法士協会](#) ↗

短 信

〈アクセス〉リハ予約に希望言語が見える化

PT紹介19,260件。非英語希望者の10日以内予約は27.4→31.3%。格差は残り、担当者の常用は22%。

出典 [Phys Ther](#) ↗

〈呼吸リハ〉日常指標だけではCOPD増悪を予測できず

フランス21施設128人、4,200回の記録。重症増悪19人。CAT・息切れ・運動成績単独のAUCは0.45～0.58。

出典 [Pulmonology](#) ↗

〈生活支援〉脳卒中後の性の悩み、支援から抜ける

LGBTQI+の脳卒中経験者18人・パートナー5人を面接。性の話題の不在や否定的対応を整理。質的研究で一般化に注意。

出典 [Disabil Rehabil](#) ↗

〈フレイル〉推定持久力の高さとフレイル発症

中国2,403人・英国4,256人。推定持久力1SD上昇の発症HRは0.92と0.82。観察研究で予防効果は未確定。

出典 [Arch Gerontol Geriatr](#) ↗

〈遠隔リハ〉デジタルツインの技術構成を整理

2021～26年の54研究をレビュー。センサー・AI・XR・通信の構成を整理。臨床効果の統合評価ではない。

出典 [Artif Intell Med](#) ↗

〈嚥下AI〉舌骨上筋エコーの測定線を自動化

371枚の画像で検討。専門家との測定線一致72.3%、手動の評価者間ICCは0.386。画像数は患者数ではない。

出典 [Med Biol Eng Comput](#) ↗

〈脊髄損傷〉車椅子使用者の手根管、超音波で評価

タイの67人・126手首。神経断面積のAUCは0.76。10mm²で感度90.5%、特異度45.2%。単独診断に注意。

出典 [Am J Phys Med Rehabil](#) ↗

〈嚥下評価〉内視鏡所見と嚥下の負担感は補完関係

化学放射線治療後の中咽頭癌38人。FEES所見と本人の負担感は一対一に対応せず。生理・生活面の両方を評価。

出典 [Support Care Cancer](#) ↗